

Fecha Última Actualización: 19-11-2022 13:45:05

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Carlos Arturo Pinto Carrasco
Edad : 78a 10m 4d
Dirección : Cerro Bravo 1601

Rut : 4.847.101-3
Fecha Nacto: 15/01/1944
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 9512971
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 4931 3503

N° Epicrisis
328785

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim

Fecha Ingreso : 01/10/2022 17:41

Días Estadía : 49

Unidad de Egreso : Medicina Cuidados Básicos 5° Piso

Fecha Egreso : 19/11/2022 13:11

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Hematuria

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Emolizaciones De Malformaciones Vasculares Y Otras Terapias Enovascuales Cerebrales (Exceptua Trat. Endovascular Del Anuerisma) - 14/10/2022 13:30 - Claudio A Valencia Valencia

Epidemiología

Resumen Clínico

INFORME DE ALTA MÉDICA 18/11/2022

Nombre: Carlos Pinto Carrasco
RUT: 4847101-3
Edad: 78 años

MOVIMIENTOS DURANTE HOSPITALIZACIÓN

FI HSR: 01/10
FI UTIM: 03/10/22
FI UROLOGÍA: 06/10/22
FI UPC: 15/10/22
FI UTIM: 07/11/22
FI SALA 14/11/22

ANTECEDENTES

·Médicos: Ca de próstata (ADC) en RT y HT (hasta abril 2014), cistitis actínica (angioembolización diferida por cámara hiperbárica (60 sesiones con término reciente), litiasis vesical blanda, RAO en hospitalizaciones previas. ICC con FEp de etiología coronaria (DA pendiente resolver, SCA SSDST 07/22 y angina estable (MIBI con leve isquemia inferolateral, probablemente subendocárdica)), BCRI, ERC, HTA, DM2 IR
·Quirúrgicos: Cirugía de rodilla
·Fármacos: NPH 20-10, Amlodipino 10, HCTZ 50, ATV 20, AAS 100, espironolactona 12,5, enalapril 20, bladuril 200 c/8, sulfato ferroso 200, paracetamol SOS
·Alergias: (-)
·Hábitos: TBQ (-), OH (hace años, refiere gran cantidad previamente), drogas (-)
·Hospitalizaciones recientes: Mayo y junio 2022 por hematuria macroscópica y RAO que requirió CUP y transfusión. Julio 2022 por IAM SSDST tipo 2 por anemia en contexto de hematuria.
·Sociales: Autovalente, vive con hijas quienes se encargan de sus fármacos. Antes constructor
·Inmunizaciones:

Fecha Epicrisis : 19/11/2022 13:45

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:09

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

ANAMNESIS

Paciente con antecedentes descritos, consulta por cuadro de una semana de evolución caracterizado por hematuria y retención urinaria asociada, sin fiebre, síntomas anémicos, respiratorios ni gastrointestinales. Se agrega dolor en fosa lumbar izquierda. Ingresa al SU en buenas condiciones generales, afebril, normotenso, normocárdico, sin requerimientos de oxígeno. Al examen físico se describe bien perfundido, con mucosas secas, RR2T SS, MP + SRA, abdomen BDI, puño percusión esbozada a izquierda, sin edema de EEII ni signos de TVP. Se solicitan exámenes generales en los que destaca Crea 6.66, BUN 115.4, K 6.03, PCR 178.7.

Ingresa a UTIM para continuar manejo por falla renal aguda e hiperkalemia.

LABORATORIO INGRESO

01/10: Hb 9.9 Hcto 28.1 VCM 89.9 CHCM 35.3 GB 6670 RAN 5000 (75.1%) Plaq 317000 PCR 187.7 TP 13.9 INR 1.14 TTPA 35.5 Crea 6.66 BUN 115.4 ELP 128/6.03/103 Ac úrico 8.6 Mg 2.5 Ca 9.3 Alb 3.2 GPT 8 GOT 13 FA 57 GGT 17 BilT 0.70 BilD 0.27 LDH 365 glucosa 224 proteínas 6.7 lipasa 31 amilasa 52
GSV: pH 7.26 pCO2 27.0 HCO3 11.9 BE -13.7

MICROBIOLOGÍA

01/10: OC inflamatoria, UC (+) Klebsiella BLEE 100.000 UFC. PCR COVID (-) VHB NR VHC NR VIH NR.

IMÁGENES

01/10 PieloTAC: Engrosamiento parietal vesical difuso, sugerente de vejiga de lucha.

DIAGNÓSTICOS INGRESO:

- Insuficiencia renal aguda sobre crónica
- Etiología post renal por cistitis actínica y hematuria
- Síndrome urémico
- Sospecha de ITU

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN:

HDN: Estable, con anemia progresiva Hb 9.9 -- 8.6 -- 8.5 -- 8.6, secundaria a hematuria persistente. Sin transfusión o DVA. El día 15/10 paciente evoluciona grave, con apremio respiratorio, por lo que es trasladado a UPC, se coloca línea arterial braquial izquierda, IOT y se inician vasoactivos en contexto de sedación, los cuales se titulan a la baja y se suspenden el 07/11. Evoluciona con anemia estable, y sin nuevos requerimientos de DVA.

Respiratorio: Posterior a angioembolización, el 15/10 presenta episodio de desaturación 60% y taquicardia hasta 130 lpm, PA 121/56 mmHg, sin fiebre. Logra saturación hasta 87% con mascarilla a 15 L, respiración toracoabdominal, roncus abundantes bilaterales, aspiración de secreción hemática abundante. AngioTAC (-) TEP, pero con signos de congestión pulmonar y derrame pleural bilateral (posiblemente NAAS y sobrecarga de volumen). Se presenta a UPC para IOT. Además FBC 25/10 muestra puntos erosivos sangrantes que ceden con lavado con suero. Se extuba el 29/10 con salida a VMNI y weaning frustrado con nuevo requerimiento de VMI 04 - 06/11, saliendo posteriormente a VMNI y CNAF. Luego con requerimientos de O2 a la baja hasta suspensión al ingreso a SALA. El 16/11 inicia con nuevo cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, en contexto de congestión por anuria, con aumento progresivo de oxígeno hasta CNAF. Se acuerda con familiares manejar proceso de fin de vida en domicilio, por lo que se titula a soporte de O2 por naricera, con manejo de disnea con opioides con buena respuesta. Se educa a familiares en manejo de disnea con bolos de Morfina en domicilio, medio parche de Fentanilo instalado en el hospital el 18/11, un día previo a su alta.

Infeccioso: Al ingreso ITU por Klebsiella BLEE manejada con Imipenem, completando 10 días, con evolución favorable. El 15/11, taquicárdico, taquipneico, normotenso, afebril, con GB en 6560, PCR 200, por lo que se pancultiva y se inicia tratamiento empírico con vancomicina + imipenem, la cual se suspende el 17/11 dado limitación del esfuerzo terapéutico. Se rescata cultivo punta catéter con Candida, la cual recibe 1 dosis de anidulafungina, en contexto de manejo de fin de vida se decide suspender.

Renal: Creatinina basal 2.1, secuestrado de Ca de próstata con cistitis actínica post RT, con episodios de hematuria recidivantes. Ingresa con deterioro de función renal con creatinina hasta 6.6/ BUN 115 y síndrome urémico. Se instaló CUP con salida de contenido hemático + coágulos; con recuperación de diuresis y normalización de función renal llegando a creatinina 2.63/BUN 61.1. PieloTAC sin HUN, sólo signos de engrosamiento pared vesical y de vejiga de lucha. Impresiona como descompensante de etiología post renal e ITU concomitante. Evoluciona con parámetros nitrogenados al alza en contexto de FOM en UCI,

Fecha Última Actualización: 19-11-2022 13:45:05

Página 3 de 4

conocido por equipo de Nefrología, el 17/10 se instala CVC transitorio con 1° sesión TRR SLED 6 horas el 18/10 y que se mantiene con TRR hasta el 07/11. Actualmente con catéter disfuncional, paciente sin intención de continuar HD, se retira CHD el 12/11 y se suspenden HD. Se firma desistimiento por hija, paciente evoluciona con anuria y síndrome urémico.

Urológico: Ca Próstata 2012-2014 manejado con RT + HT. Cursa con hematuria persistente, última hospitalización en junio 2022 por RAO que se manejó con irrigación vesical, logrando retiro de CUP. Angioembolización en ese entonces descartada, recibe 60 sesiones de cámara hiperbárica. Se hospitaliza con recidiva de hematuria, se emboliza 14/10 con buena evolución, pero al traslado a UTIM presenta hematuria nuevamente (08/11) autoresolutiva.

Cardiológico: Antecedentes de cardiopatía coronaria en hospitalización previa, pendiente estudio coronariográfico (Se encuentra CNG del 2016 sin informe, y evaluación por cardiología con plan de PCI a ADA). A su ingreso con troponinas al alza pero ECG sin SDST. Cuenta con MIBI 2016 con leve isquemia inferolateral, FEVI conservada, y EcoTT 2021 con FEVI 61%, AI levemente dilatada, IM y Ao leves. Por hematuria con múltiples recidivas, se desestima continuar con plan de resolución de ADA o inicio de DAPT.

Cuidados paliativos no oncológico: Paciente con múltiples hospitalizaciones por complicaciones de cáncer de próstata, asociado a ERC terminal con necesidad de TRR crónico, sin embargo paciente desestima hemodiálisis. Dado paciente anúrico, evoluciona con uremia y congestión importante asociado a insuficiencia respiratoria. En este contexto, se desestiman mayores intervenciones, se suspenden antibióticos y se inicia manejo de cuidados de fin de vida con parche y BIC de Fentanyl, se suspende CNAF y se decide junto con equipo de cuidados paliativos y familiares, hospitalización domiciliaria con manejo de confort y soporte en proceso de final de vida.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO:

1. Insuficiencia respiratoria aguda - Paciente en proceso de fin de vida
2. ITS CVC asociada a Candida Albicans
3. Síndrome Urémico: Falla renal etapa V- anuria con rechazo a HD
3. Shock hemorrágico - Hematuria (resuelto)
4. Miopatía del paciente crítico
5. Trastorno de deglución
6. Alcalosis respiratoria + acidosis metabólica AG N
7. Antecedentes: Ca. próstata (adenocarcinoma en RT y HT hasta 2014), cistitis actínica (manejada con cámara hiperbárica sin respuesta), HTA, DM2 IR, ERC, ICC FEp, BCRI, C. coronaria (pend. resolver ADA), litiasis vesical, RAO recurrente

Diagnóstico de Egreso

Cistitis Actínica -
Insuficiencia Respiratoria aguda parcial -
Edema pulmonar -
Síndrome Urémico -
Itu Kpn Blee -
Miopatía Del Paciente Crítico -
Insuficiencia Respiratoria Aguda - Insuficiencia Respiratoria Aguda
Candidemia Invasora -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en contexto de fin de vida. Con manejo sintomático por parte de cuidados paliativos, paciente en deterioro progresivo, anúrico, dificultad respiratoria progresiva con medidas de confort paliativas.

Plan Post Alta

Indicaciones
- Reposo en cama
- Régimen: licuado + líquidos espesos según tolerancia. Agua a confort en sorbos aislados que no superen los 5cc
- Sentado en 90°, Pausado, asistido.

Medicamentos:

- Morfina (ampolla 10mg/ml) dar 1 mg por vía subcutánea en caso de sensación de falta de aire. Repetir hasta 3 veces si es necesario. En caso de no responder tras dosis repetidas, administrar Midazolam.

Fecha Epicrisis : 19/11/2022 13:45

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 19-11-2022 13:45:05

Página 4 de 4

- Midazolam (ampolla 5 mg/ml) dar 1 mg SOS en caso de agitación y/o angustia (posterior a dosis de Morfina).
- PEG 15gr en 200cc cada 12-8hrs vía oral, hasta lograr deposiciones.
-

Paciente en manejo de fin de vida. Con alto riesgo de fallecer durante las próximas 24-48 horas posterior a su alta en domicilio.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Agua Para Comfort

Medicamentos :

Controles

INTERNO


Camila Alejandra Mamani Patty
Becado/Residente


Rodrigo Naser Abarzua
Médico Tratante (Staff)